

Patient de 67 ans, tabagique et hypertendu se présente à votre consultation pour des douleurs du mollet gauche lorsqu'il marche 20 mètres, depuis 6 mois. Il a consulté un orthopédiste qui a diagnostiqué une arthrose de hanche débutante. Un bilan angiologique a mis en évidence un ABI à 0.65 à gauche et 0.84 à droite avec des flux monophasiques en distalité à gauche. Présence d'une grande veine saphène de 4 mm de diamètre à gauche.

Angio-CT scan: étage aorto-iliaque sans sténose. A droite, courte sténose de l'artère fémorale superficielle à mi-cuisse. A gauche, occlusion longue de l'artère fémorale superficielle depuis son origine avec reprise poplitée sus-géniculée. Il a bénéficié d'un entraînement à la marche et un traitement de statine et d'aspirine a été instauré.

Quelle proposition thérapeutique vous semble la plus adaptée ensuite:

- A. Pontage fémoro-poplitée sous-géniculé prothétique du MIG
- B. Angioplastie et stenting de l'artère fémorale superficielle par voie endovasculaire
- C. Pontage fémoro-poplitée sus-géniculé veineux inversé du MIG**
- D. Mise en place d'une prothèse totale de hanche G
- E. Thrombolyse intra-artérielle in situ

Un patient de 82 ans arrive aux urgences avec un membre inférieur D très douloureux. Le status met en évidence un pied blanc et froid sans aucun pouls périphérique palpable. Mise en évidence d'une hypoesthésie du pied avec difficulté à mouvoir la cheville et les orteils. La radiographie du thorax est sans particularité. L'ECG met en évidence un rythme irrégulièrement irrégulier.

Quelle attitude est la plus correcte ?

- A) Thrombolyse intra-artérielle
- B) Thrombo-embolctomie chirurgicale à la sonde de Fogarty**
- C) Angio-scanner de l'aorte et des membres inférieurs
- D) Echocardiographie trans-thoracique
- E) Amputation du pied